

Primeros Auxilios

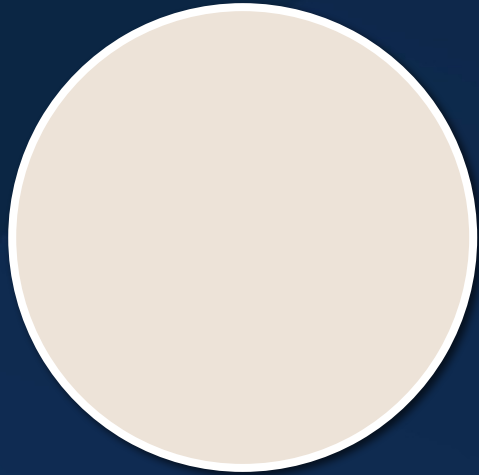
Brigada de primeros auxilios

Con el apoyo de

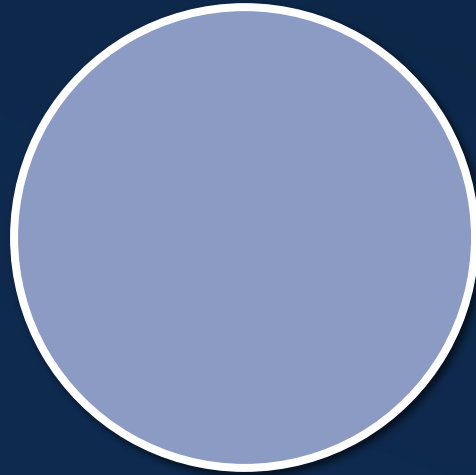


ADVANCED
CRITICAL CARE

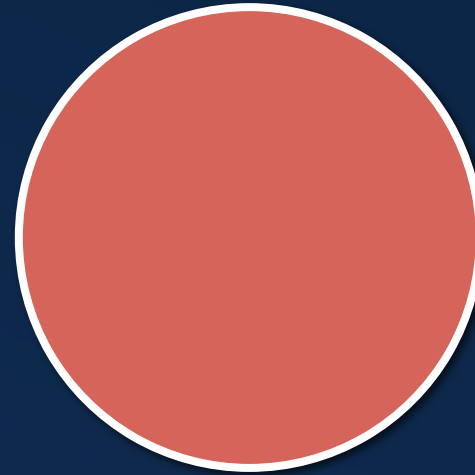
TIPOS DE COLORACION



Pálido



Cianótico



Rojizo



Ictérico

1.5.1 Manejo de la vía aérea y control de la columna cervical

❑ Se debe de evaluar que la vía aérea se encuentre permeable.

❑ La causa más común de obstrucción es por que la lengua se ha relajado y está obstruyendo el paso del aire al sistema respiratorio.

MANIOBRAS PARA ABRIR LA VÍA AÉREA

INCLINACIÓN DE CABEZA – ELEVACIÓN DE MENTÓN (Sin trauma)



- Coloca una mano en la frente y empuja suavemente hacia atrás.
- Con los dedos de la otra mano, eleva el mentón hacia arriba.
- No comprimas los tejidos blandos bajo el mentón.

TRACCIÓN MANDIBULAR (Con trauma cervical sospechado)



- Coloca tus dedos detrás de los ángulos de la mandíbula.
- Eleva la mandíbula hacia adelante sin mover la cabeza.
- Mantén la boca ligeramente abierta.



**Si se sospecha de lesión en
cuello**

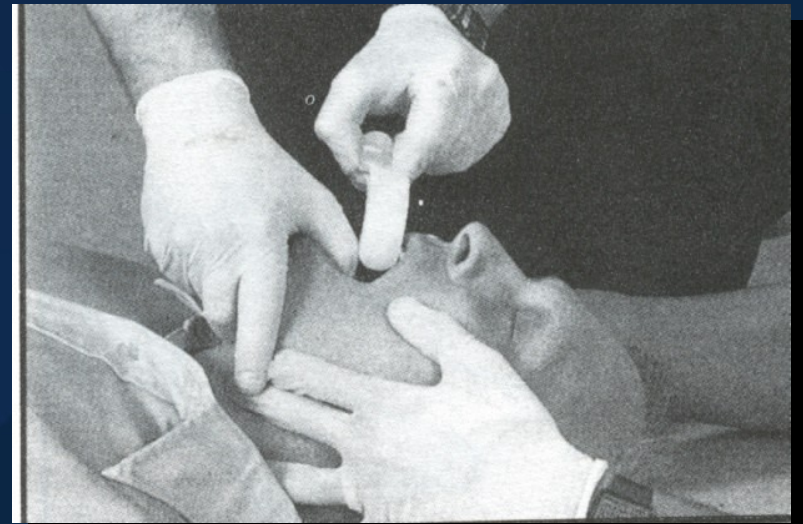
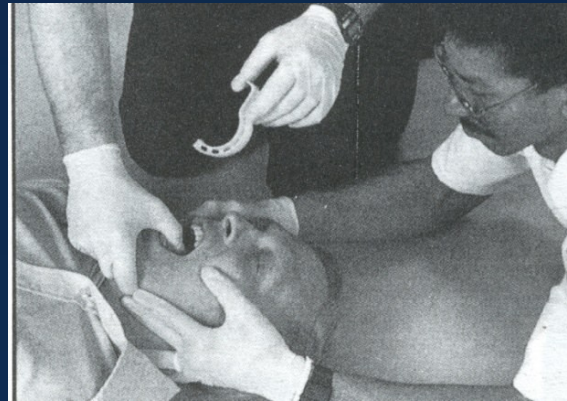
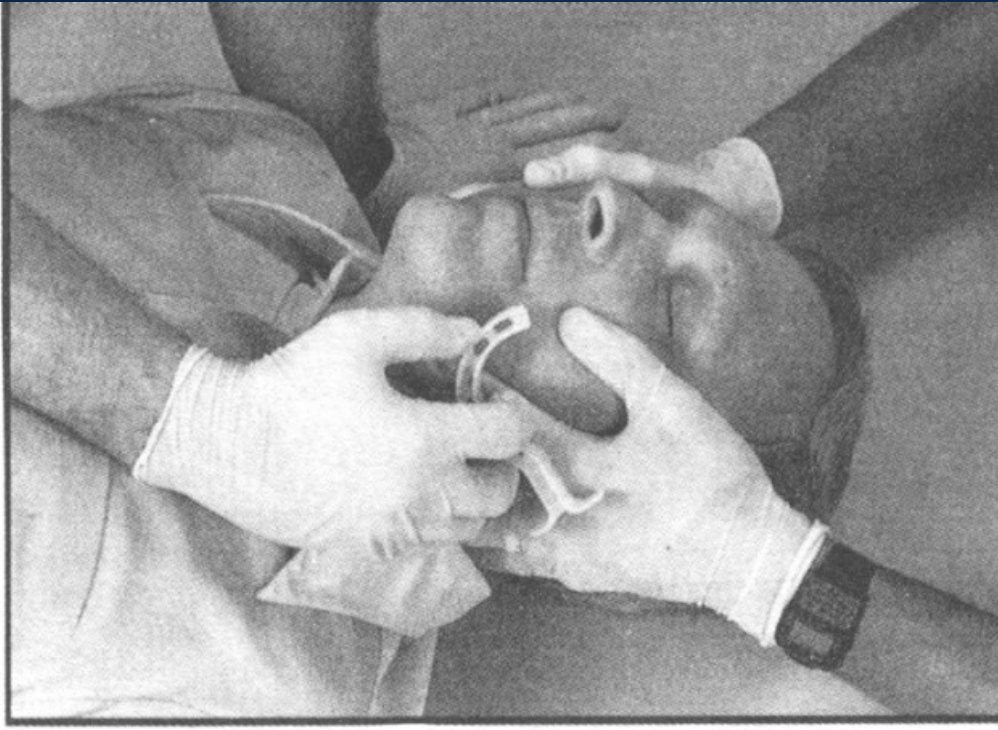


**Maniobra de hiper extensión de
cuello**

COLOCACIÓN DE CÁNULA OROFARINGEA



A



1.5.2 Buena respiración (breathing)

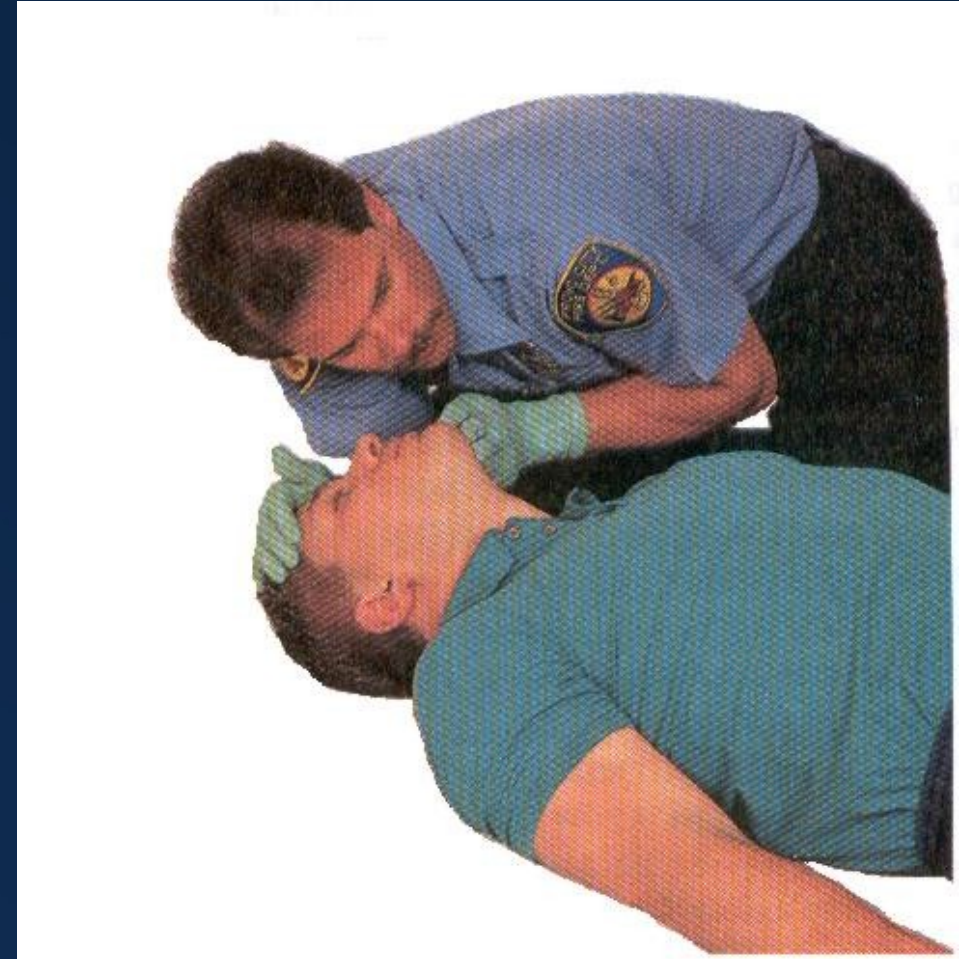


- ❑ Corroborar que está respirando.
- ❑ Verificar la frecuencia respiratoria.
- ❑ Observar los movimientos del tórax.

VER

ESCUCHAR

SENTIR



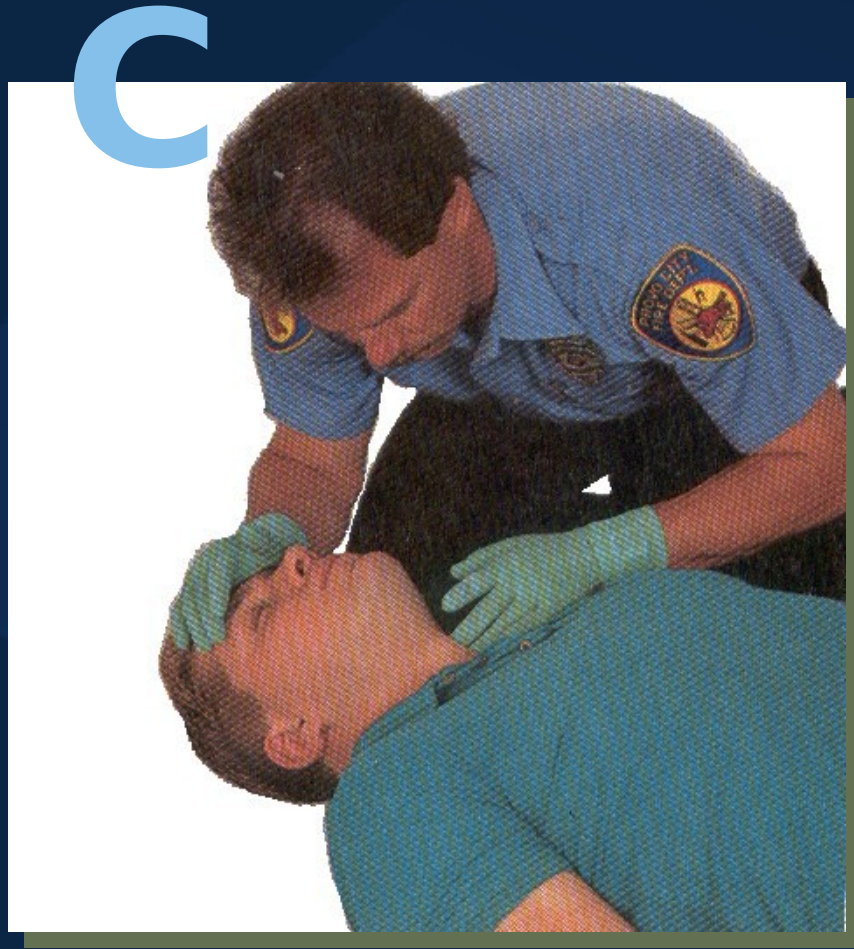
1.5.3 Circulación con control de hemorragias



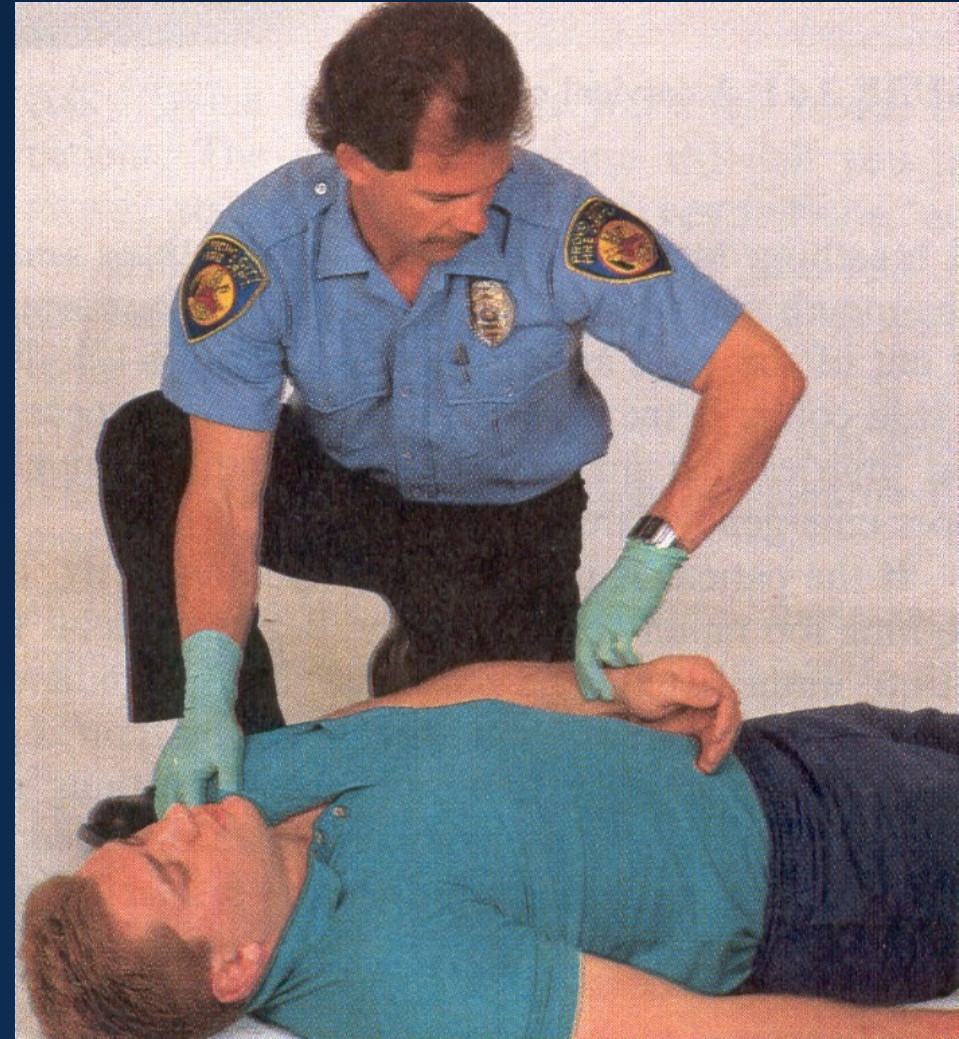
VERIFICAR PULSO

Aun que el paciente esté respirando, puede ser que el oxígeno que llega a los pulmones no esté oxigenando su cuerpo si la persona no tiene pulso.





PULSO CAROTIDEO



PULSO RADIAL

1.5.4 Déficit neurológico



- A. Alerta (responde espontáneamente a los estímulos del medio).
- V. Responde a estímulos verbales.
- D. Responde sólo a estímulos dolorosos.
- I. Inconsciente o estado de coma (no responde a ningún tipo de estímulo).



1.5.5 Exponer y examinar a la víctima protegiéndola del ambiente



Es importante exponer el tórax, el abdomen y las extremidades de los pacientes respetando su pudor. Como se podrá observar en el capítulo correspondiente, se les deberá proteger del frío, de la lluvia y del calor intenso.



1.6 Evaluación secundaria



PREsentación

Dolencia principal

Antecedentes específicos del caso

Edad

Salud anterior

Medicamentos

Alergias



UNIDAD 2. APOYO VITAL BÁSICO



2.1 Atragantamiento

DEFINICIÓN

El atragantamiento parcial o total es una emergencia que puede causar la muerte en pocos minutos si no se actúa rápido.



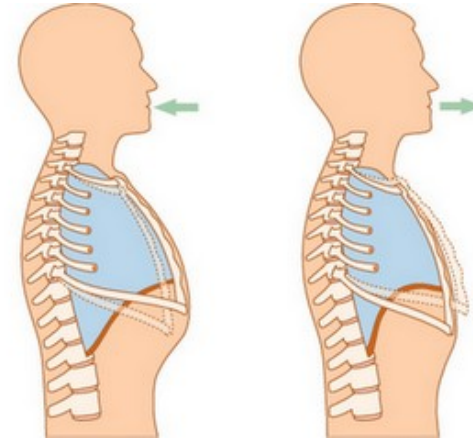
2.1.1 Atragantamiento parcial



Tos fuerte.



**Su voz se
escucha
aunque tosa.**



**Puede inhalar
y exhalar.**



**Sólo debe
expulsar el
objeto que le
obstruye.**

2.1.2 Atragantamiento total

CARACTERÍSTICAS.

- ❖ La persona es capaz de hablar, respirar o toser.
- ❖ La imagen muestra la postura universal de un atragantamiento total.
- ❖ Aplicar maniobra de Heimlich.

SIGNOS DE OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA



PARCIAL

- Puede hablar o toser.
- Sonidos respiratorios.
- No puede toser con fuerza.
- Ansiedad leve.



TOTAL

- No puede hablar, toser ni respirar.
- Se agarra el cuello.
- Cianosis (color azulado).
- Pérdida de la conciencia.

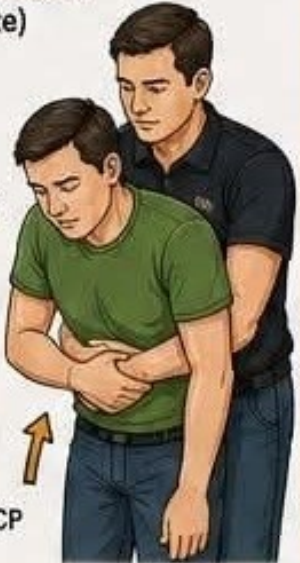
¿QUÉ HACER?

- Anima a toser si la obstrucción es parcial.
- Si es total y el paciente está consciente: realizar maniobra de Heimlich.
- Si está inconsciente: iniciar RCP y revisar la vía aérea.

TÉCNICA DE HEIMLICH

(Paciente consciente)

- 1 Párate detrás del paciente y rodea su cintura con tus brazos.
- 2 Coloca un puño entre el ombligo y el esternón.
- 3 Toma el puño con la otra mano y realiza compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba.
- 4 Repite hasta que el objeto sea expulsado o el paciente pierda la conciencia.
- 5 Si queda inconsciente, inicia RCP y revisa la vía aérea.





NO apliques Heimlich en:

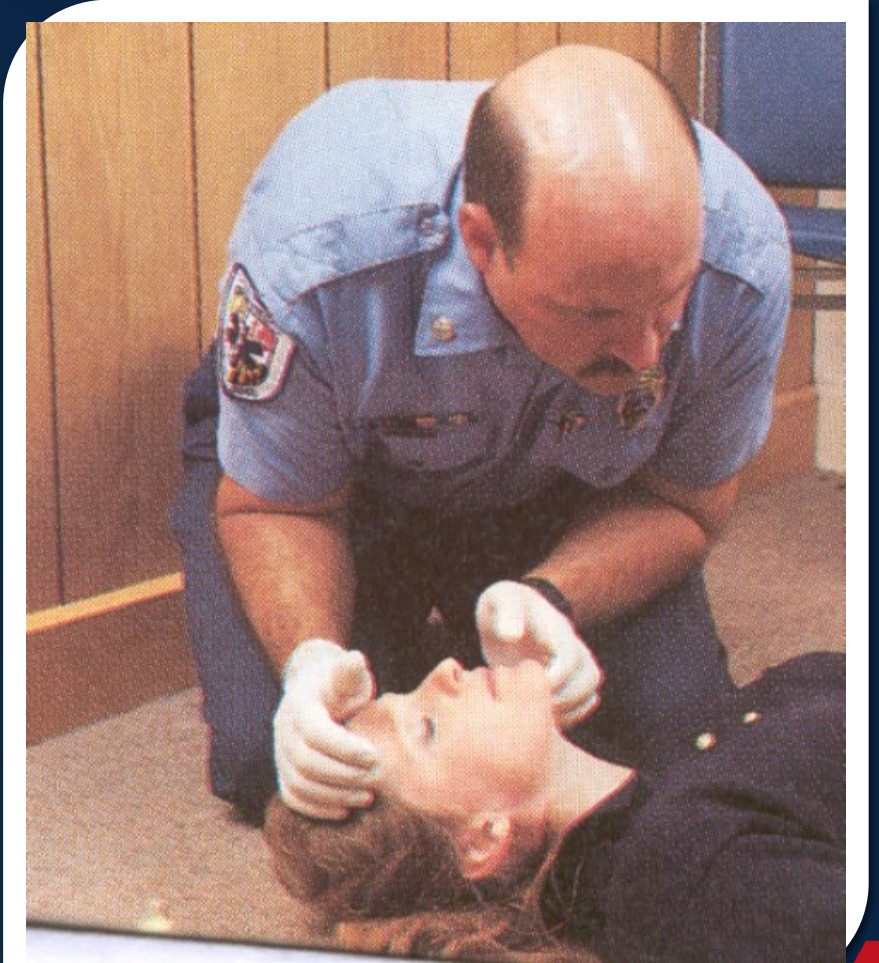
- Embarazadas avanzadas
- Lactantes (< 1 año)
- Personas obesas (considera compresiones torácicas)

2.1.4 Técnica de “barrido” con el dedo (Procedimiento)

Abrir boca de
la víctima.

Detener la
lengua y
levantarla
hacia arriba.

Retirar
cualquier
objeto que
esté
obstruyendo.



2.2 Paro cardiorrespiratorio



DEFINICION.



Es la interrupción brusca, inesperada y reversible de la circulación y la respiración espontáneas.

Para revertir esta situación usted debe iniciar la re-animación cardiopulmonar mediante dos acciones: Ventilación asistida y compresiones torácicas.


$$30 \times 5 = 150 = 2 \text{ min}$$



$$\begin{aligned} 30 \times 5 \\ = 150 \\ = 2 \text{ min} \end{aligned}$$



UNIDAD 3. HEMORRAGIAS



Concepto: *Hemorragia* es aquella pérdida de continuidad de los vasos sanguíneos que ocasiona la salida de la sangre hacia un espacio distinto al que la contiene.



SE DIVIDEN EN:

Internas

La sangre se queda
dentro del cuerpo:
no se ve

Externas

La sangre sale por
una herida: sí se ve

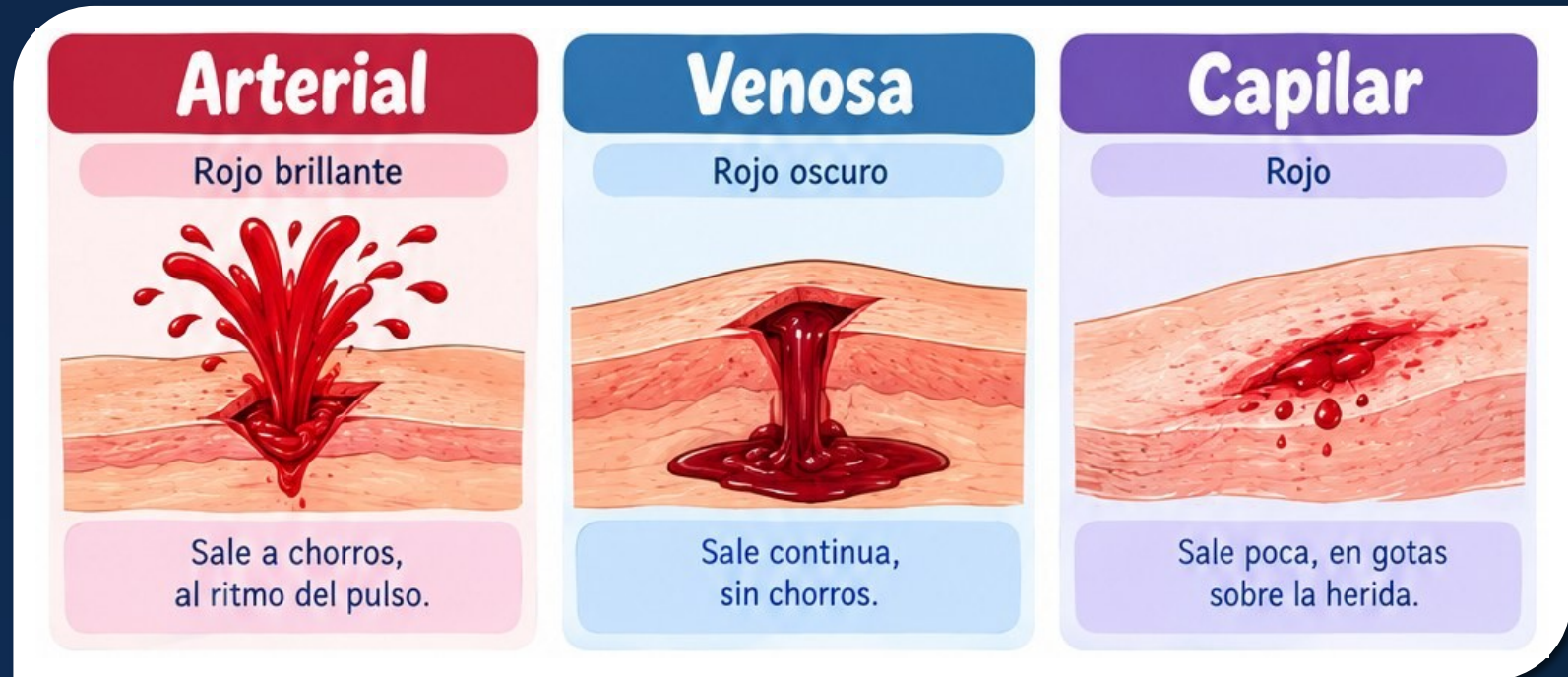
3.1 Clasificación de las hemorragias externas:



Arterial. Salida de sangre color rojo brillante, salida abundante y fuerte que coincide con las pulsaciones o latidos.

Venosa. Salida de sangre de color obscuro, flujo continuo y pausado.

Capilar. Hemorragia superficial con salida de sangre escasa.



3.2 Gravedad de las hemorragias



Estos son los factores que determinan la gravedad de una hemorragia.

- a) Tipo y calibre del vaso lesionado.
- b) Si la sangre fluye al interior o al exterior del organismo.
- c) Origen real de la hemorragia.
- d) Cantidad de sangre perdida.
- e) Edad y peso del paciente.
- f) Condición física y estado general del individuo.

3.3 Métodos de contención de hemorragias



- Colocar al paciente en una posición cómoda.
- Controlar la hemorragia colocando una gasa o apósito seco y limpio comprimiendo firmemente con una mano. Si se llena de sangre poner encima de este unos seco.
- Elevación del miembro afectado por arriba del corazón.



3.3 Métodos de contención de hemorragias (continuación)



- Si persiste la hemorragia ejercer presión indirecta sobre el vaso sanguíneo que se encuentre anatómicamente más cercano al sitio afectado produciendo así una disminución del flujo sanguíneo.
- Mantener al paciente en calma y tranquilo.



Control de una hemorragia externa



SI VES UNA HEMORRAGIA IMPORTANTE:

1

**MANTÉN
LA CALMA.**



2

**APLICA PRESIÓN
DIRECTA SOBRE
LA HERIDA CON
UNA TELA LIMPIA.**



3

**ELEVA LA
EXTREMIDAD SI ES
POSIBLE Y NO HAY
FRACTURA EVIDENTE.**



4

**LLAMA
INMEDIATAMENTE
A EMERGENCIAS.**



IMPORTANTE:



**NO RETIRES EL
MATERIAL EMPAPADO
DE SANGRE;
AGREGA MÁS ENCIMA
SI ES NECESARIO.**



**NO PIERDAS TIEMPO
BUSCANDO REMEDIOS
IMPROVISADOS.**



SI LA SANGRE ATRAVIESA EL VENDAJE:



**CONTINÚA EJERCENDO
PRESIÓN CONSTANTE.**



RECUERDA:

**DETENER LA
PÉRDIDA DE
SANGRE ES LA
PRIORIDAD.**

Elevación de la Extremidad



Una extremidad que esta sangrando intensamente deberá elevarse por encima del nivel del corazón de la víctima, sin dejar de ejercer una presión directa o indirecta.

Presión Directa



Realizarla con un apósito, gasa estéril o lienzo limpio colocándolo sobre la herida y presionando firmemente con la palma de la mano.



4. Estado de shock



Definición

Disfunción grave y generalizada del flujo sanguíneo hacia los tejidos la cual al no ser tratada a tiempo puede desencadenar el mal funcionamiento del organismo el metabolismo y como consecuencia la muerte inminente del individuo.

Signos y síntomas

- Palidez.
- Disminución temperatura.
- Sudoración.
- Alteración del nivel de conciencia.
- Respiraciones rápidas y trabajosas.
- Pulso radial débil.
- Llenado capilar mayor a 2 seg.

Choque Hipovolémico



Obedece a la pérdida de líquidos corporales por tres causas:

- +Hemorragia externa
- +Hemorragia interna
- +Deshidratación

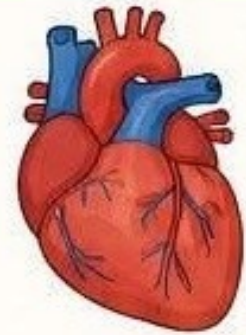


Choque Cardiogénico



Es consecuencia de un funcionamiento inadecuado del corazón debido a padecimientos preexistentes.

2 SHOCK CARDIOGÉNICO



Se produce cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre.

CAUSAS

- Infarto agudo de miocardio
- Insuficiencia cardíaca grave
- Arritmias severas

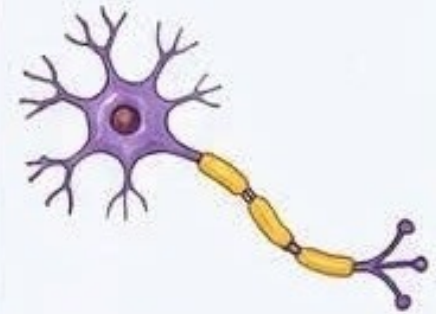
Choque Neurogénico



Lo provoca la pérdida del control del sistema nervioso cuando la médula espinal es lesionada.

5

SHOCK NEUROGÉNICO



Ocurre por lesión del sistema nervioso que provoca pérdida del tono vascular.

CAUSAS

- Traumatismo medular
- Lesiones neurológicas severas

Choque Anafiláctico



Se produce cuando una persona tiene contacto con alguna sustancia a la que es alérgica en extremo y provoca una reacción violenta en el organismo.

4

SHOCK ANAFILÁCTICO



Reacción alérgica grave y generalizada.

CAUSAS

- Medicamentos
- Alimentos
- Picaduras de insectos

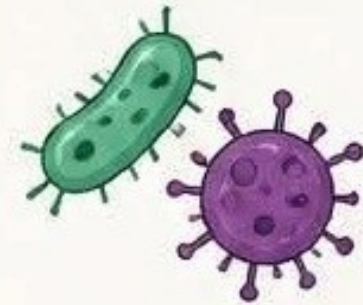
Choque Séptico



Ocurre en caso de infección grave, cuando las toxinas se incorporan al torrente sanguíneo afectando la circulación.

3

SHOCK SÉPTICO



Resultado de una infección grave que desencadena una respuesta inflamatoria sistémica.

CAUSAS

- Neumonía
- Infecciones urinarias complicadas
- Infecciones abdominales

4.1 Tratamiento de emergencia del estado de Shock



- a) Efectuar la valuación inicial.
- b) Activar el servicio médico de urgencia.
- c) Mantener una vía aérea permeable y favorecer la respiración.
- d) Controlar las hemorragias.
- e) Colocar al paciente con los pies elevados 30 cm. por arriba del nivel de la cabeza en posición que se conoce como Trendelemburg.
- f) Cubrir al paciente.
- g) Tratar de mantener consciente al paciente.
- h) Traslado rápido al hospital.



Unidad 5. Esguinces, luxaciones y fracturas



Esguince

Ruptura de los ligamentos articulares.

Luxación

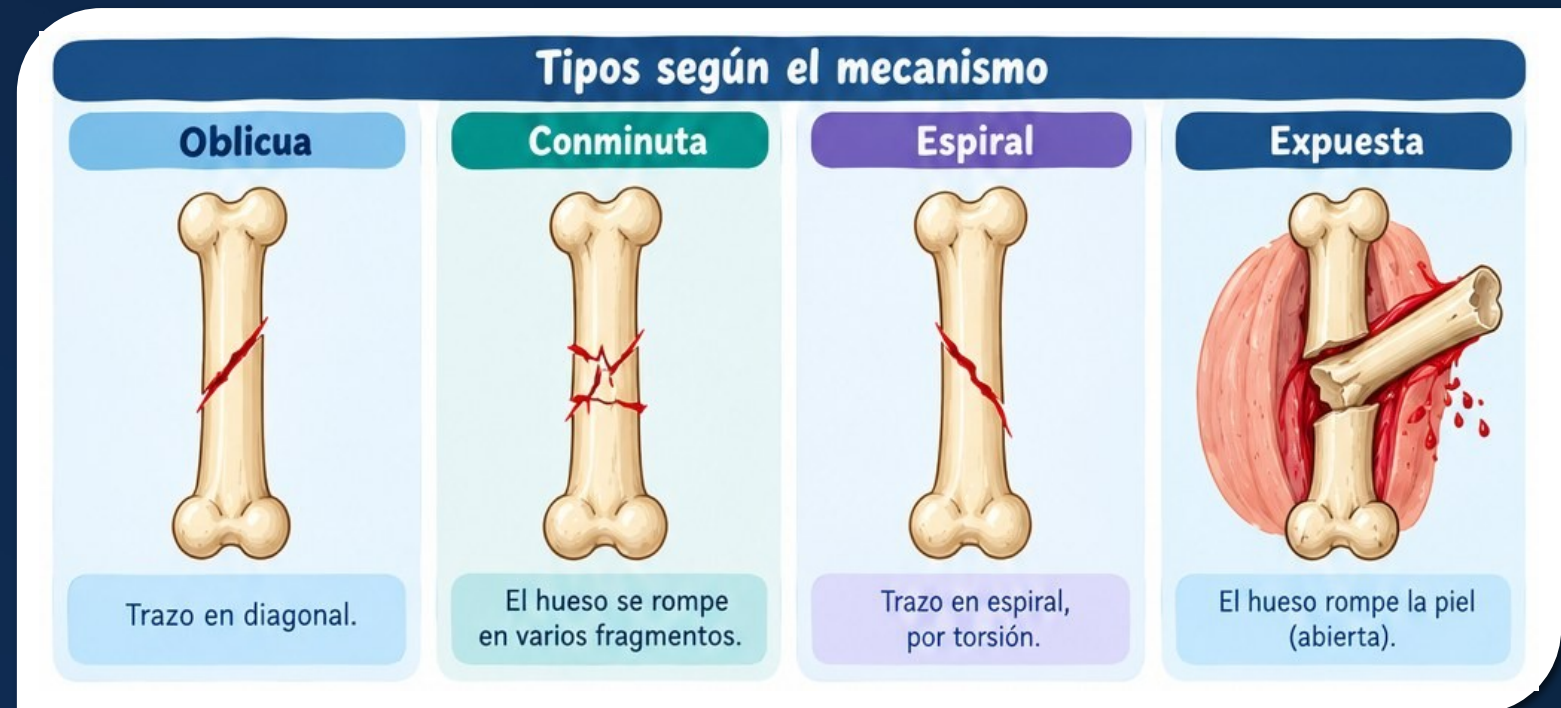
Pérdida de contacto entre los huesos de la articulación; se conoce como dislocación.

Fractura

Pérdida de la continuidad del tejido óseo.

FRACTURA:

Es la pérdida en la continuidad de un tejido óseo o hueso, incluyen huesos agrietados, astillados o completamente rotos.



Clasificación

Los métodos de clasificación de fracturas son varios, y dependen del tipo de rotura del hueso o zona corporal afectada, así como de otros factores asociados. Se pueden clasificar según su etiología en "patológicas", "traumáticas", "por fatiga de marcha o estrés" y "obstétricas".

Exposición

Dependiendo de si el punto de fractura se comunica o no con el exterior, se clasifican en:

Cerrada, si la punta de la fractura no se asocia a ruptura de la piel, o si hay herida, ésta no comunica con el exterior.

Abierta o expuesta, si hay una herida que comunica el foco de fractura con el exterior, posibilitando a través de ella, el paso de microorganismos patógenos provenientes de la piel o el exterior.



- Deformidad de la región
 - Impotencia funcional
 - Dolor intenso y localizado
 - Crepitación ósea y hemorragia (externa en caso de ser expuesta)
 - Inflamación de la región
- 

Algunas fracturas se consideran graves debido al sitio en el que se localizan por ejemplo:

- Cráneo
- Columna Vertebral
- costillas
- Pelvis



Inmovilización de fracturas

- No mover la región fracturada si no hay razón para hacerlo
- Utilizar material adecuado a la región
- Inmovilizar las dos articulaciones más próximas
- No apretar demasiado para no entorpecer la circulación



Elementos para inmovilizar



Se pueden utilizar cartones, periódicos enrollados, tablas, cobijas, etc. Estos elementos se consideran férulas, las cuales deben ser:

Cómodas

Rígidas

Seguras



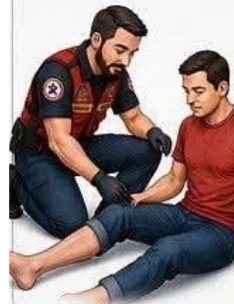
Hay varios tipos de férulas que se pueden utilizar en una emergencia:

Prefabricadas
Improvisadas
Anatómicas

CÓMO USAR LA SAM SPLINT

1 EVALÚA

Evalúa la lesión y asegúrate de que no haya heridas abiertas graves.



2 MIDE

Mide la férula desde la articulación por encima de la lesión hasta la articulación por debajo de la lesión.



3 MOLDEA

Moldea la férula con las manos para que tome la forma de la extremidad.



4 COLOCA

Coloca la férula en la extremidad, asegurándote de que quede firme y cómoda.



5 ASEGURA

Asegura la férula con vendas, cintas o correas en la parte superior, media e inferior.



6 VERIFICA

Verifica la circulación, sensibilidad y movimiento distal después de inmovilizar.



✓ Siempre inmoviliza la articulación por encima y por debajo de la lesión.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Muñeca



Antebrazo



Húmero



Tobillo



Pierna



Dedos



Complicaciones



- Hacer abierta una fractura cerrada
- Lesionar nervios, arterias y venas
- Secuelas en la movilidad
- Infección
- Trombosis grasa
- Lesionar la médula espinal
- Estado de shock

UNIDAD 6. QUEMADURAS



Una quemadura es el daño o destrucción de la piel o tejidos más profundos como el músculo y el hueso por calor o frío.

Puede darse por:

- ❑ Agentes físicos
- ❑ Agentes Químicos
- ❑ Agentes eléctricos



Quemaduras por agentes físicos

Producen quemadura por contacto directo con una fuente de calor o por calor radiante:

- Calor seco
- Calor Húmedo
- Sólidos Incandescentes
- Fricción
- Electricidad



Quemaduras químicas



Se producen por el contacto de los tejidos con sustancias químicas:

- Corrosivos
- Álcalis
- Ácidos



Signos de una quemadura



- ❖ Dolor y sensación de inflamación de la piel
- ❖ Ámpulas
- ❖ desprendimiento de la piel
- ❖ Enrojecimiento
- ❖ Hinchazón



QUEMADURAS TÉRMICAS Y QUÍMICAS: PRIMERA RESPUESTA

Responder bien en los primeros minutos *reduce* el dolor, el daño y las secuelas.

TÉRMICA



Provocada por calor, fuego, vapor, líquidos o superficies calientes.



El daño depende del tiempo y la temperatura.



Puede afectar la piel y tejidos profundos (1º, 2º o 3º grado).

QUÍMICA



Provocada por contacto con sustancias químicas corrosivas o irritantes.



El daño continúa mientras el químico siga en la piel.



Puede penetrar en la piel y causar daño profundo.

DIFERENCIAS CLAVE

VS

¿QUÉ HACER DE INMEDIATO?

- 1 Retira a la persona del foco de calor de forma segura.
- 2 Enfía la quemadura con agua limpia a temperatura ambiente por 10-20 minutos.
- 3 No apliques hielo, pomadas ni remedios caseros.
- 4 Cubre con gasa o paño limpio y suelto.
- 5 Busca atención médica si es grave o extensa.



¿QUÉ HACER DE INMEDIATO?

- 1 Retira a la persona del área contaminada.
- 2 Quita la ropa y calzado contaminados con cuidado.
- 3 Lava la piel con abundante agua por 15-20 minutos.
- 4 No neutralices la sustancia (puede empeorar el daño).
- 5 Busca atención médica inmediata.





ALERTA
HOY,
SEGURO
SIEMPRE

Se debe a la acción de las radiaciones ionizantes sobre los tejidos:

Rayos X

Rayos ultravioleta

Rayos solares



Quemadura por Electricidad



Enrojecimiento, tumefacción o carbonización

Posible pérdida del conocimiento

Posible paro cardiorrespiratorio



Quemadura de Boca Y Garganta



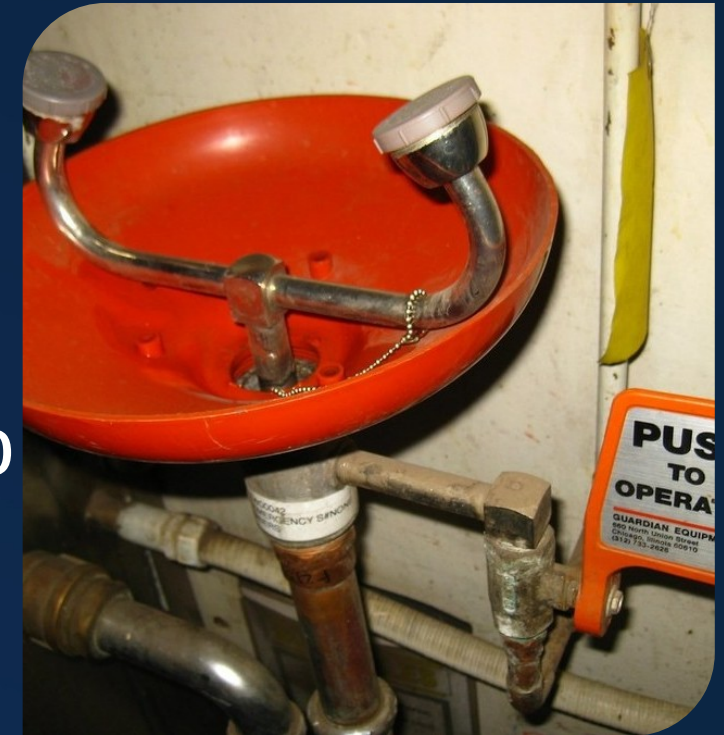
- ❖ Dolor en el área afectada
- ❖ Hinchazón en la zona
- ❖ Dificultad respiratoria
- ❖ Posible pérdida del conocimiento



Quemadura en Ojos



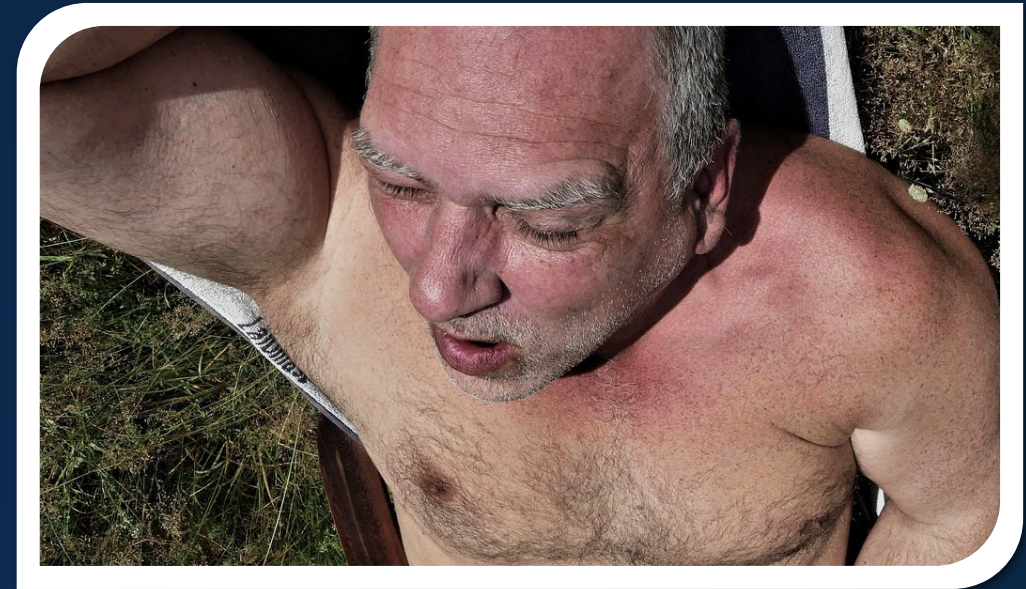
- ❖ Intenso dolor
- ❖ No tolera luz
- ❖ Párpados cerrados
- ❖ Enrojecimiento, hinchazón o lagrimeo excesivo



Quemadura Solar



- ❖ Enrojecimiento de la piel, escozor
- ❖ Hipersensibilidad
- ❖ Piel hinchada y caliente
- ❖ Ámpulas



6.2 Lesiones sistémicas por calor



Calambre por calor:

El tratamiento:

- ✓ Quitar al paciente del ambiente caliente.
- ✓ Estirar suavemente el músculo.
- ✓ Dar masaje para fomentar circulación.
- ✓ Administrar líquidos con electrolitos como las bebidas deportivas o Vida Suero Oral.

Golpe por calor

El tratamiento:

- ✓ Enfriamiento del paciente por medio de compresas de agua tibia o fría.
- ✓ Administrar líquidos vía oral.
- ✓ Trasladar.

6.3 Lesiones cutáneas por frío

Definición: Es la congelación de tejidos corporales como consecuencia a la exposición a temperaturas muy frías.

El tratamiento:

- ✓ Colocar al paciente en un ambiente caliente.
- ✓ Colocar la parte corporal afectada sobre una superficie caliente.
- ✓ Calentar a temperatura corporal.
- ✓ Si es profunda la lesión no se recomienda el recalentamiento.
- ✓ Evitar dar masajes.



6.4 Lesiones sistémicas por frío



Hipotermia: Es la condición en la cual la temperatura interna corporal disminuye por debajo de los 35°C, afecta a individuos sanos que no estando preparados para ello y son expuestos a condiciones adversas.

Las causas:

- Permanecer al aire libre durante el invierno sin protegerse.
- Caer de una embarcación en aguas frías.
- Usar ropas húmedas por mucho tiempo cuando hay viento o hace mucho frío.



Factores Que Agravan Una Quemadura



PRIMORDIALES

- Extensión
- Profundidad
- Localización

ADICIONALES

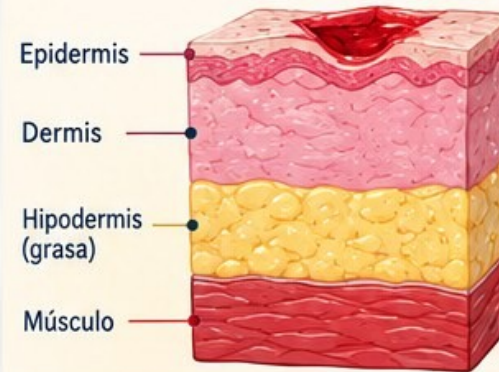
- Edad
- Sexo
- Enfermedad

Clasificación de las quemaduras

- Quemaduras 1er grado: Afectan la capa más superficial de la piel. Los síntomas son enrojecimiento de la piel, piel seca, dolor intenso tipo ardor e inflamación moderada.
- Quemaduras 2do grado: afecta la segunda capa de la piel provocando ampollas, ámpulas, inflamación del área, color rosado o rojo brillante y dolor.

1er grado

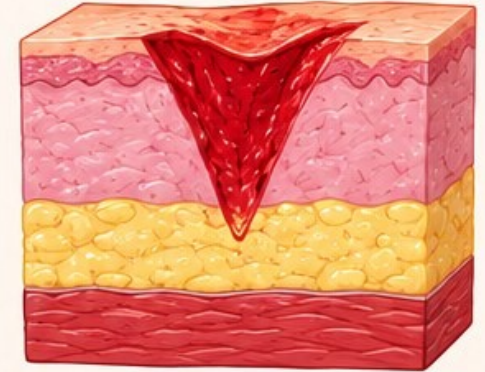
Alcanza: Epidermis



Enrojecimiento · dolor ·
hinchazón

2º grado

Alcanza: Epidermis y dermis



Ampollas · dolor intenso ·
piel húmeda

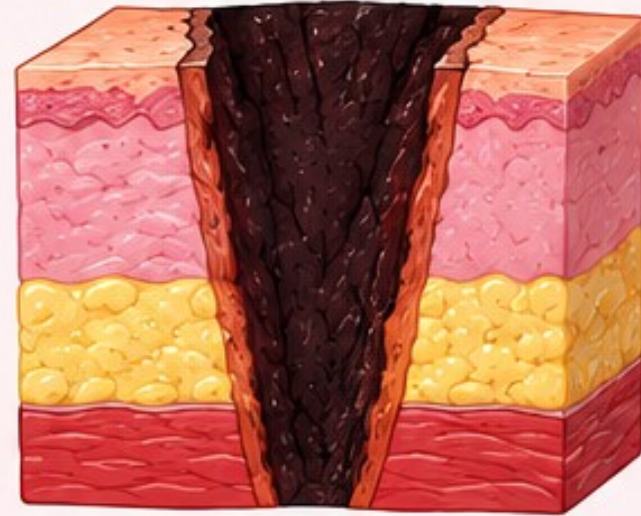
Clasificación de las quemaduras (continuación)



- Quemaduras 3er grado: afecta toda la piel, músculos, tendones, nervios, hueso, se observa color blanco carbonizado, la piel pierde elasticidad y no existe dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Este tipo de quemadura se produce por contacto prolongado con elementos calientes, cáusticos o por electricidad.

3er grado

Alcanza: Todas las capas



Piel blanca o carbonizada ·
sin dolor en la zona

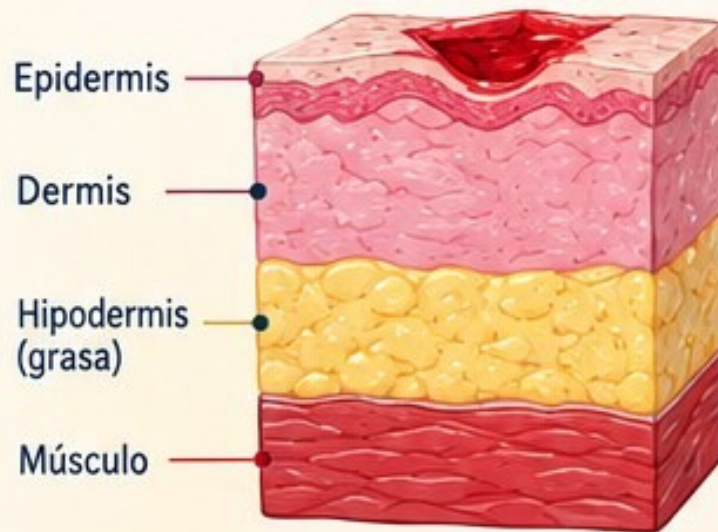
Grados de las quemaduras



ADVANCED
CRITICAL CARE

1er grado

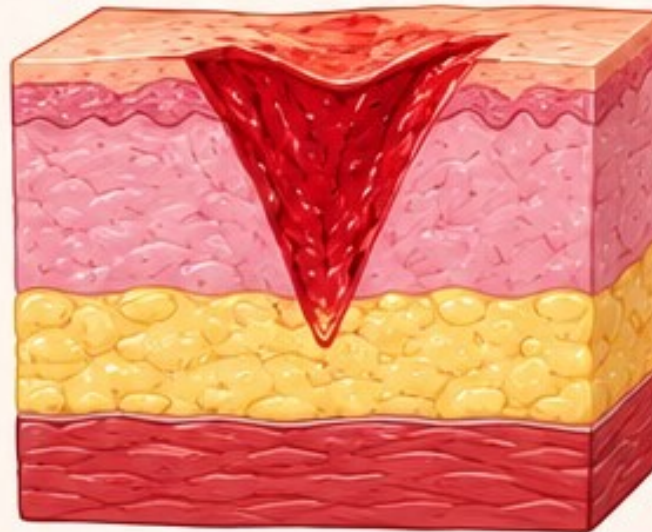
Alcanza: Epidermis



Enrojecimiento · dolor ·
hinchazón

2º grado

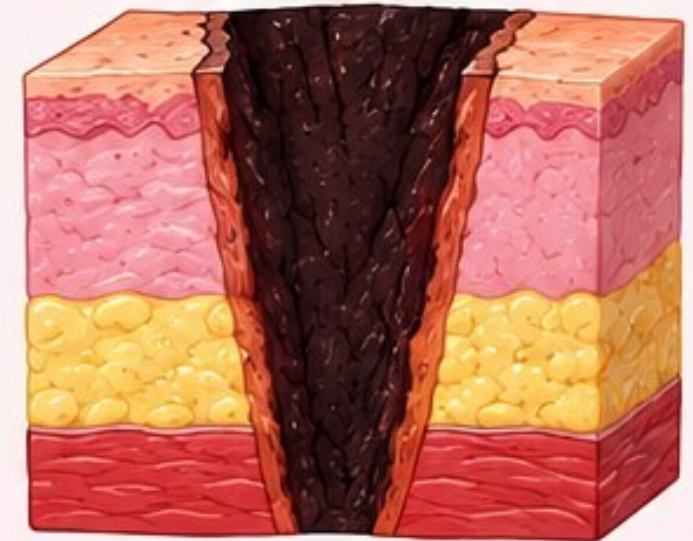
Alcanza: Epidermis y dermis



Ampollas · dolor intenso ·
piel húmeda

3er grado

Alcanza: Todas las capas



Piel blanca o carbonizada ·
sin dolor en la zona

Regla De los 9

Determina la extensión de la quemadura en un adulto

9% cabeza y cuello

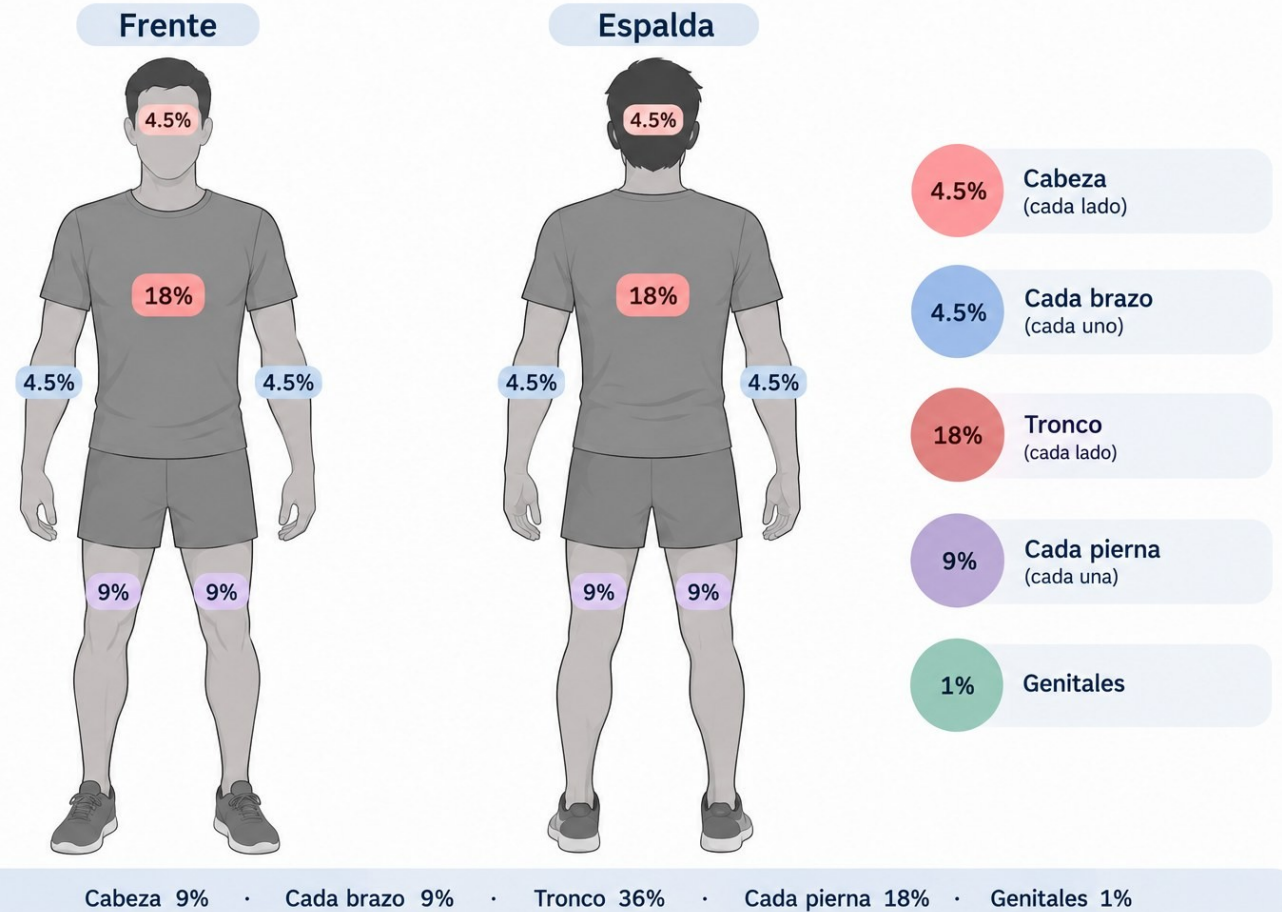
9% cada miembro torácico

18% cara anterior del tronco

18% cara posterior del tronco

18% cada miembro pélvico

1% genitales



Tratamiento General



- Aplicar agua a chorro (depende la SCQ)
 - Tranquilizar al lesionado
 - Colocar en posición cómoda
- Retirar objetos que compriman la zona
 - Retirar prendas calientes
 - Cubrir con gasas estériles (secas)
- En lesiones faciales, confeccionar una máscara

- ❖ Inmovilizar extremidades quemadas
- ❖ Prevenir estado de shock
 - ❖ Dar agua a beber
- ❖ Aplicar RCP si es necesario
- ❖ Trasladar inmediatamente a un hospital



Prohibiciones



❖ **NO:**

- ❖ Retirar nada que esté adherido
- ❖ Aplicar lociones, ungüentos ni grasa
- ❖ Romper ámpulas
- ❖ Retirar piel desprendida
- ❖ Tocar área lesionada
- ❖ Juntar piel con piel

UNIDAD 7. CONVULSIONES Y EPILEPSIA

Causas: Una convulsión se da cuando el cerebro deja de funcionar normalmente a causa de una lesión, enfermedad, fiebre o infección, la actividad eléctrica del cerebro se vuelve irregular.



CONVULSIÓN

ACTUAR BIEN, PUEDE SALVAR UNA VIDA

Una convulsión es una **alteración temporal y súbita** de la actividad eléctrica del cerebro que puede causar movimientos involuntarios, pérdida de conciencia y cambios en la respiración.



¿QUÉ HACER? PRIMEROS AUXILIOS

1 MANTÉN LA CALMA Tu tranquilidad ayuda a la persona.	2 PROTEGE A LA PERSONA Retira objetos peligrosos alrededor.	3 COLOCA EN EL SUELO Si está de pie o sentado, acuéstala suavemente en el suelo.	4 COLOCA EN POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD Cuando termine la convulsión y si está inconsciente, colócala de lado.	5 PROTEGE LA CABEZA Coloca algo suave (ropa, toalla) debajo de la cabeza.	6 NO RESTRINGAS SUS MOVIMIENTOS No sujetes a la persona ni pongas objetos en su boca.
---	---	--	--	---	---



7.1 Características de la epilepsia.



- Pérdida de conocimiento y caída al suelo.
- Contracciones involuntarias de grandes grupos musculares.
- Síntomas. La percepción subjetiva (sólo la persona las siente) de olores, colores o sonidos (olor a almendras, lucecitas, zumbidos, etc.).
- Al finalizar el enfermo entra en una especie de coma o estado estuporoso, despiertan sin recordar lo ocurrido, tienen fuertes dolores de cabeza y de todo el cuerpo, manifestando estar muy agotado.



Epilepsia · Conducta ante una crisis



- ✓ No dejar solo al paciente
- ✓ Observar las características de las crisis
- ✓ Despejar el área
- ✓ Aflojar la ropa
- ✓ Proteger la cabeza
- ✓ Colocar lo de lado
- ✓ Esperar a que la crisis termine sola

NO

✗ No introducir ningún objeto en la boca

UNIDAD 8. INTOXICACIONES Y ENVENAMIENTOS.



Intoxicación. Reacción del organismo a la entrada de un tóxico el cual puede causar lesiones o inclusive la muerte.

Veneno. Un veneno o toxina es cualquier sustancia peligrosa para el cuerpo. Es posible tragarlo, inhalarlo, inyectarlo o absorberlo a través de la piel.



UNIDAD 8. INTOXICACIONES Y ENVENAMIENTOS.



Síntomas

- Irritación ocular.
- Alteración del estado de conciencia.
- Falta de oxígeno.
- Nauseas, mareo y vómito.
- Convulsiones.
- Coloración azulada de los labios o quemaduras en las comisuras de la nariz y la boca.

tratamiento

- ✓ enjuagar la zona afectada con agua abundante.
- ✓ Alejar a la persona de la fuente de intoxicación.
- ✓ Quitar ropa contaminada.
- ✓ Revisar si la persona está consciente, respira y tiene pulso.
- ✓ NO inducir el vómito.
- ✓ Trasladar al hospital.

Mordedura de serpiente



En la mayoría de los casos las serpientes muerden al ser molestadas, para determinar la peligrosidad se debe tomar en cuenta la cantidad de veneno inoculado



- Taquicardia
- Vómito con sangre
- Probable ceguera transitoria
- Midriasis



- ❖ Edema
- ❖ Escalofríos
- ❖ Necrosis
- ❖ Dolor intenso
- ❖ Adormecimiento y hormigueo en la zona



Picadura de animales ponzoñosos



Signos y síntomas generales:

- Dolor intenso
- Edema
- Adormecimiento
- Contracciones musculares
- Taquicardia



- Durante los primeros minutos después de la mordedura succionar el veneno con el equipo adecuado.
- Mantenerlo en reposo
- Torniquete (última alternativa)
- Traslado inmediato

TRIAGE EN EL AREA DE DESASTRES



Que es un desastre?



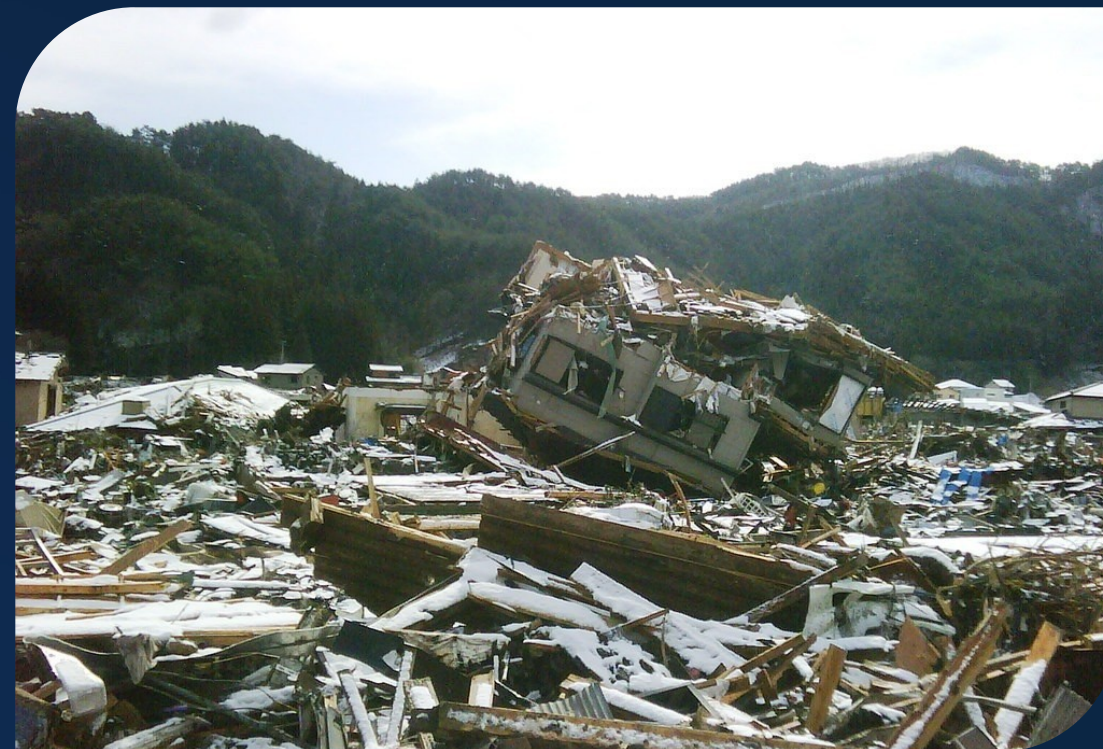
- Un desastre es un evento calamitoso, repentino o previsible, que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos. Aunque frecuentemente están causados por la naturaleza, los desastres pueden deberse a la actividad humana.



Que es un desastre? (continuación)



- (VULNERABILIDAD + PELIGRO) /CAPACIDAD = DESASTRE
- Un desastre ocurre cuando un peligro tiene efectos en las personas vulnerables.
- Un peligro, combinado con vulnerabilidad e incapacidad para reducir sus consecuencias negativas potenciales, da lugar a un desastre.



Clasificación de pacientes en el área de desastres



Triage (del francés triage = clasificación) es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.

Esta clasificación, que se ha ido empleando en la guerra, se ha extendido para las catástrofes. En estas se clasifica a los pacientes por colores:

Blanco

persona fallecidas.

Negro

las posibilidades de recuperación son nulas. En algunos triages diferencian el negro que es el paciente agonizante del blanco en que ya ha fallecido.

Rojo

cuando el paciente tiene posibilidad de sobrevivir y la actuación médica debe ser inmediata.

Amarillo

pacientes que presentan una situación de urgencia con riesgo vital.

Verde

paciente levemente lesionado, que puede caminar y su traslado no precisa medio especial.

TRIAGE S.T.A.R.T Simple Triage And Rapid Treatment



¿Puede caminar el paciente?

Evaluación inicial en la escena

SI

Código verde, últimos en ser trasladados.

Moverlos a un área segura

Sirven de apoyo y para cuidar de otros pacientes

TRIAGE START

SIMPLE TRIAGE AND RAPID TREATMENT

CLASIFICACIÓN RÁPIDA PARA SALVAR MÁS VIDAS

El Triage START es un método de clasificación de pacientes en situaciones de múltiples víctimas. Permite identificar rápidamente a quienes necesitan atención inmediata, priorizando los recursos disponibles.



PASOS DEL TRIAGE START



CATEGORÍAS DE PRIORIDAD



VENTILACION PRESENTE?



SI

NO

>30/MIN

<30/MIN

ABRIR VIA
AEREA

RESPIRA
?

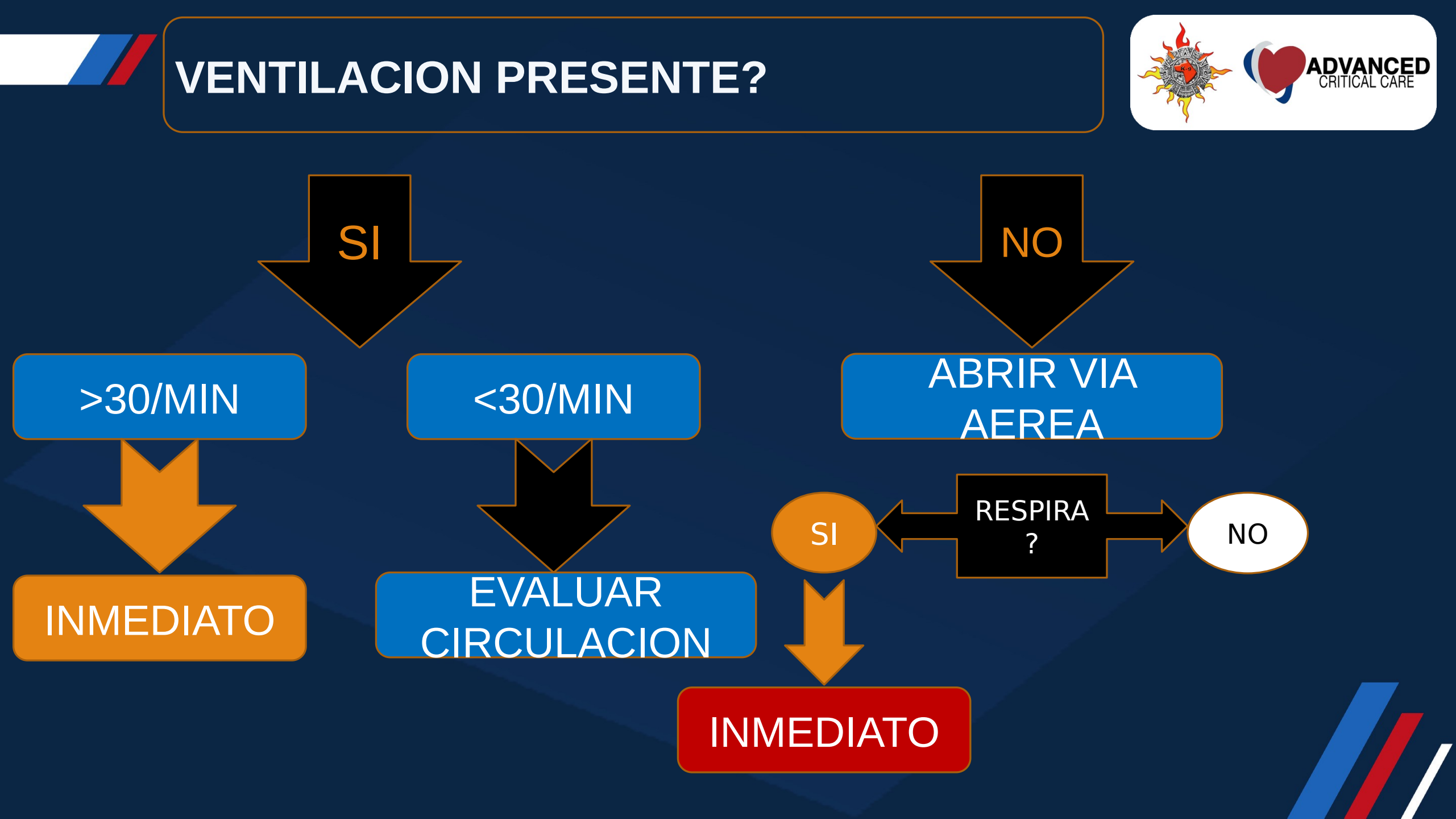
SI

NO

INMEDIATO

EVALUAR
CIRCULACION

INMEDIATO





NIVEL DE CONCIENCIA



**NO obedece órdenes
simples**



INMEDIATO

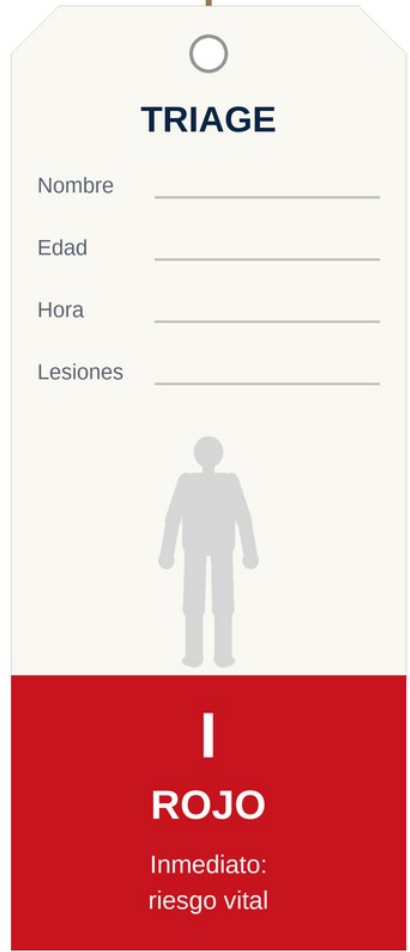
SÍ obedece órdenes simples



DEMORADO

AREA ROJOS 1a. Prioridad

- Víctimas en estado crítico recuperable.
- Tratamiento y transporte inmediato son requeridos.
- Es necesario cuidado intensivo permanente, para mantenerlas con vida.



TRIAGE

Nombre

Edad

Hora

Lesiones



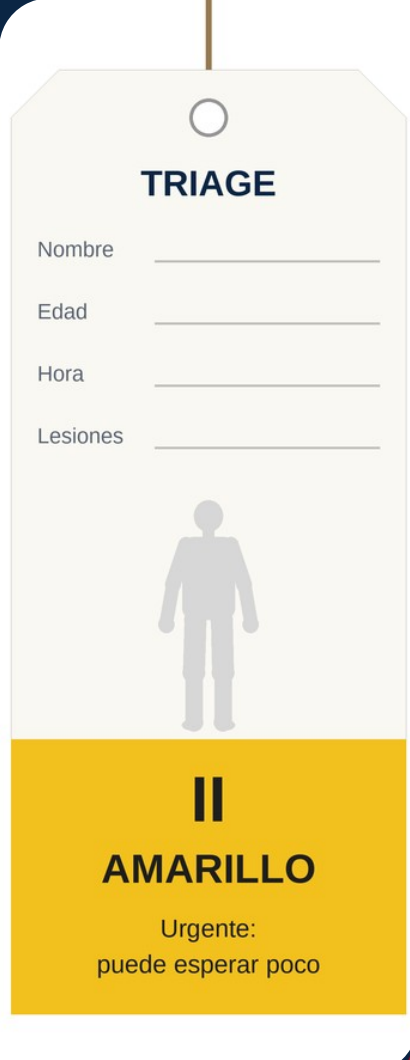
I

ROJO

Inmediato:
riesgo vital

AREA AMARILLOS 2a. Prioridad

- **Víctimas con daños moderados y severos.**
- **Transporte de urgencia es requerido, pero puede dilatarse hasta que hallan sido removidos las víctimas de 1º prioridad, es decir los del área rojos.**



TRIAGE

Nombre _____

Edad _____

Hora _____

Lesiones _____



II

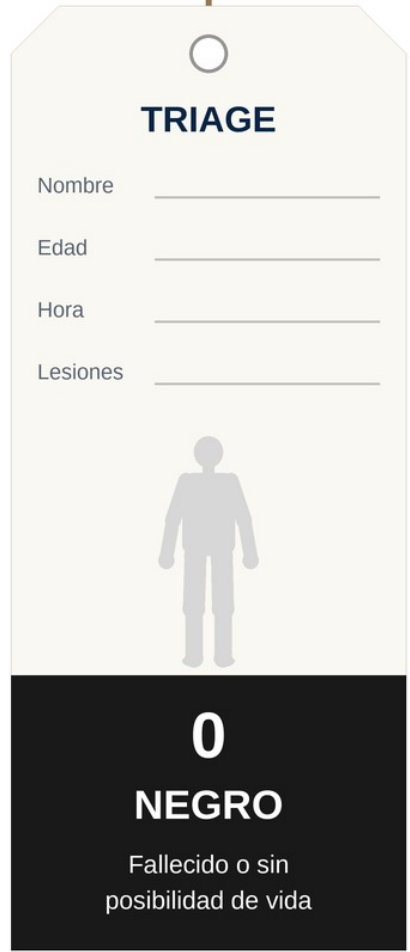
AMARILLO

Urgente:
puede esperar poco

AREA NEGROS 3a. Prioridad

Pacientes no viables, es decir sin posibilidad de sobrevida, o que no tolerarían la evacuación.

- **No requieren transporte y solo tratamiento de soporte.**
- **Esta prioridad NO SIGNIFICA “NO TRASLADAR” o “NO ASISTIRLO”, significa atención y/o traslado luego de resolver los Rojos y Amarillos, pero previo a los verdes.**
- **En la clasificación de estas víctimas, es donde se debe tener un especial cuidado y una sólida experiencia, para no cometer errores.**



TRIAGE

Nombre

Edad

Hora

Lesiones



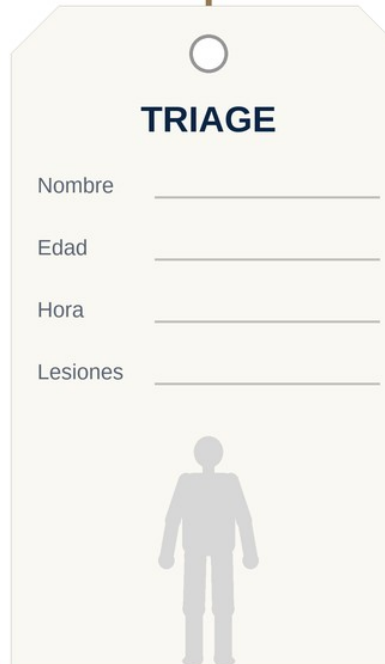
0

NEGRO

Fallecido o sin posibilidad de vida

AREA VERDES 4a. Prioridad

- **Víctimas con daños ligeros o sin daños.**
- **No es necesario transporte de urgencia, pueden ser evacuados al final, en forma masiva y en transporte no sanitario.**
- **La evaluación y el tratamiento en consultoría con el Hospital suele ser suficiente.**
- **Son lesionados, a veces asintomáticos, pero en los que se debe esperar el desarrollo de un cuadro clínico.**
- **Necesitan observación y, probablemente, tratamiento inmediato, en caso de cambiar su estado**



TRIAGE

Nombre _____

Edad _____

Hora _____

Lesiones _____



III

VERDE

Leve:
camina, puede esperar

AREA BLANCOS 5a. Prioridad

- Muertos. Son los fallecidos en el lugar. Serán depositados en un área a determinar para su identificación y actuación judicial.
 - Se deberán descontaminar y desvestir como cualquier otra víctima.
 - Deberán estar cubiertos por bolsas de bioseguridad para el transporte de cadáveres.
- 

Tarjetas de triage



0	I	II	III
NEGRO	ROJO	AMARILLO	VERDE
Fallecido o sin posibilidad de vida	Inmediato: riesgo vital	Urgente: puede esperar poco	Leve: camina, puede esperar

CONCLUSIONES



- Debido a que las lesiones sufridas en accidentes pueden afectar cualquier parte del cuerpo humano demanda que la evaluación y la atención primaria sean efectuadas de manera inteligente y eficiente, sobre las bases de individualización, previamente al transporte del lesionado.



CONCLUSIONES (continuación)



- Por lo que es esencial que el personal que brinda los primeros auxilios preste sus servicios con excelencia a fin de elevar la calidad y la capacidad de supervivencia de nuestros pacientes, actuando de forma ejemplar bajo la primicia de no producir un daño mayor al que ya sufre el paciente.



¡AGRADECIMIENTOS!



- La labor de servir a las personas en situaciones de gravedad, enfermedad o accidente es una tarea que no es fácil de ejercer, más sin embargo cuando existe la intención de aprender para ser mejor y hacer las cosas de manera correcta con el único objetivo de ayudar a los demás, para proteger lo más valioso de cada persona que es la vida misma, hace que sea una labor digna de ser admirada y **agradecida**.



¡AGRADECIMIENTOS! (continuación)



- ¡Gracias a ti que cada día haces la diferencia en tu entorno ayudando, colaborando para hacer de tu empresa un lugar donde todos se sientan seguros, protegidos y salvaguardados!



¡Gracias!

Brigada de primeros auxilios

Con el apoyo de



ADVANCED CRITICAL CARE